

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 3:07:28

Página 1 de 7

Información Paciente

Nombre : Mirza Eugenia Riveros Droguett
Edad : 59a 3m 21d
Dirección : Rio Itata 1057

Rut : 8.969.998-3
Fecha Nacto: 04/02/1963
Comuna : La Granja

N° Archivo : A492094
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5015 2186

N° Epicrisis
308534

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 21/05/2022 04:39

Días Estadía : 4

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 25/05/2022 03:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

21/05/2022 07:51:15

B.Chavez

INGRESO UPC

21-05-2022 06H30.

Paciente: Mirza Riveros Droguett.

Edad: 59 años

RUT: 8969998-3

FI HSR:21-05-2022 02H37

FI UCI: 21-5-2022 HR:06H30

Antecedentes:

Morbidos:

.HTA

.DM 2 NIR

.obesidad.

Med: losartan-atorvastatina-HCl-metformina-NPH 28 U aspirina.

Historia:

Remitido desde HPH con historia de ser trasladado por familiar a SU por compromiso abrupto de conciencia encontrado en el piso con pérdida del control del esfínter urinario y vómitos, Ingresa en G 8 pupilas mióticas, levemente reactivas, no emite lenguaje, paresia hemicuerpo derecho, retira al dolor mirada a izquierda.

Se realiza TAC cerebral con Hematoma intraparenquimatoso hemisferio izquierdo 31 cc de volumen HSA silviana izquierda efecto de masa con desviación de línea media en angioTAC de cerebro se observa aneurisma de arteria cerebral media izquierda hemorragia intraventricular en ventrículos laterales 3er y 4to ventrículo.

H y H 4 Fisher IV WFN 4.

Se traslada por SAMU a HSR ingresa a urgencias 02H37, se suspende sedación con G 7/15 con ultimo TAC cerebral 00H27, se decide repetir TAC cerebral 8H00 para evaluar evolutividad de lesión intracraneal y definir conducta.

Ingresa a UCI 6H30 intubada sin LA sin CVC, se instala LA braquial derecho y CVC yugular derecho con quia ecográfica.

Se indica traslado a TAC cerebral de control (Dan hora en radiología 8H15).

Actualmente en SAS 1 fenta-propop en VMI AC/V bien adaptada con FC 45 x min con PAM 70.

ID:

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 03:07

Página 1 de 7

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 3:07:28

Página 2 de 7

Hematoma intraparenquimatoso FT izquierdo-Hemovertrículo ventrículo lateral izquierdo-3er y 4to ventrículo.
HSA Silviana izquierda.
Aneurisma ACI izquierda.
HTA-DM2 IR-obesidad.

Diagnóstico: Hemorragia Subaracnoidea De Arteria Cerebral Media

21/05/2022 07:51:15

B.Chavez

Actualmente en SAS 1 Fenta-propio.

pupilas mióticas hiporeactivas.

mueve ESI al dolor.

Tendencia bradicárdica hipotensiva se maneja con volumen.

S foley.

SAS 1 fenta-propio.

AC/V

pupilas isocóricas hiporactivas mióticas.

TOT sin secreciones Tb.

cuello corto sin bocio.

torax simétrico csps ventilados rr 2 t

abdomen distendido rshs disminuidos.

extremidades sin edema sin TVP.

Plan:

Mantener normotensión hasta resolución de aneurisma roto.

Mantener VMI con fenta propio SAS 1 hasta TAC cerebral de control y luego reevaluación urgente con neurocx.

Control exámenes manejo metabólico.

Normoglicemia.

Control de invasiones.

21/05/2022 09:43:55

J.Castro

ingresa en la madrugada hic frontotemporal izquierdo ,aneurisma bifurcación carotídea en angiotc. tc control sin cambios respecto a ingreso.

sedado

pupilas mióticas isocóricas

localiza con esizquierda

manejo activo

angiografía cerebral.

21/05/2022 16:25:28

J.Castro

Se realiza angiografía que muestra aneurisma trilobulado bifurcación aci izquierdo, cuello ancho, no fue posible embolizar.

coma .

pupilas isocóricas.

hemiplejía derecho.

flexión anormal izquierda.

Se conversa caso en equipo neurocirugía, con cirujanos vasculares de equipo, dado estado neurológico,y características de lesiones se decide manejo no quirúrgico dado mal pronóstico.Se conversa y se explica caso y pronóstico a familia quienes están de acuerdo con manejo.

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 03:07

Página 2 de 7

21/05/2022 17:18:09

C.Alarcon

1° día de hospitalización HST / UCI.

Diagnósticos:

-Hematoma intraparenquimatoso FT izquierdo-Hemoventriculo ventrículo lateral izquierdo-3er y 4to ventrículo.

-HSA Silviana izquierda.

-Aneurisma ACI izquierda.

-HTA-DM2 IR-obesidad.

ingresa en la madrugada del 21/5/2022 : Hematoma Intracerebral frontotemporal izquierdo , aneurisma de la bifurcacion carotidea en angioTAC . TAC control sin cambios respecto a ingreso.

--> sedada (SAS 2) .

pupilas mióticas isocóricas

localiza con extremidad superior izquierda.

Paciente de extrema gravedad.

Se evaluó su situación , siendo pasado a Hemodinamia en Glasgow=7 (sin sedación).

En la tarde , aproximadamente 15:00 horas se realiza angiografía : que muestra aneurisma trilobulado con bifurcación en ACI izquierdo, con cuello ancho, por lo que no fue posible embolizar por parte de especialista (Dr. Zamora) .

Es traída de nuevo a UCI , pero aún con sedación , se ve paciente en coma .

pupilas isocóricas.

hemiplejía derecho.

flexión anormal izquierda.

Se retira toda sedación para evaluar su situación .

Se conversa caso en equipo Neurocirugía, con Cirujanos Vasculares de equipo, y dado el estado neurológico, y características de lesiones cerebrales, se decide manejo NO quirúrgico, dado el mal pronóstico vital.

Se conversa y se explica caso y pronóstico a familia quienes están de acuerdo con manejo.

Así: Pronóstico vital muy reservado. Sin indicación formal de neurocirugía. Sin sedación: sólo localiza con EESS izquierda. Además, con tendencia a bradicardia severa sostenido y respiración paradójica.

--> pronóstico vital ominoso a corto plazo.

--> familia enterada y conversado personalmente con ellos.

22/05/2022 10:05:09

V.Oliva

NEUROCIRUGÍA

Paciente grave, hipertensa, bradicardica, afebril. Sin sedación desde ayer.

GCS V1, O1, M2= 4

pupilas anisocóricas con midriasis no reactiva a izquierda.

Motor: postura de decerebración izquierda.

-Por empeoramiento de estado neurológico y elevados riesgos quirúrgicos que no superan sus beneficios, paciente fuera de alcance neuroquirúrgico

-Seguimiento por equipo

22/05/2022 19:01:55

J.Ulloa

ANTECEDENTES

HTA, DM 2 no IR, Obesidad. Medicación: losartan, atorvastatina, Hidroclorotiazida, metformina, Insulina NPH 28U, Aspirina.

EVOLUCION

Paciente cursando internación (día 2) por HSA silviana aneurismática H&H 4 /Fisher IV/ WFNS 4

- Aneurisma trilobulado de la bifurcación de ACI Izquierda (3 lobulos) con cuello ancho

- Herniación sub faxial de vasos de ACA Izquierda secundario a efecto de masa por hematoma

- Tratamiento endovascular frustró (x cuello ancho de aneurisma)

Al momento sin sedación con GSC 3/15, anisocoria (midriasis derecha 4mm), con signos de descerebración a la valoración, revalorado por Neurocirugía (fuera de alcance Neuroquirúrgico), ventilando en IOT/ARM ¿ CPAP 6/6/28% - Pafi 207, hemodinámicamente hipertensa, bradicardica. Función renal BUN 9.9 / diuresis 3060 (acumulado + 300 ml), desde lo infectológico sub febril, parámetros en ascenso (Leucocitosis 12610, PCR 17), con tratamiento ATB AMS empírico a posible Neumonía broncoaspirativa.

SE DA INFORME A FAMILIAR EXPLICANDO DIAGNOSTICO, EVOLUCION CLINICA ACTUAL, RESULTADO DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS, TRATAMIENTO RECIBIDO, ESTADO ACTUAL, PRONOSTICO Y POSIBLE COMPLICACIONES DURANTE LA INTERNACION.

Se informa a familiares de cuadro clínico actual, fuera de alcance Neuroquirúrgico y de pronóstico ominoso.

EXAMEN FISICO

GLASGOW 3/15, pupilas anisocóricas ¿ midriasis derecha 4mm, mucosas orales húmedas con TET, campos pulmonares ventilados, ruidos cardiacos rítmicos sincrónicos, abdomen blando depresible, RHA disminuidos, extremidades con dorso flexión al examen neurológico básico, extremidades tibias con buen llenado capilar bilateral.

Pres. Arterial: 171/74

PAM: 109

Frec. Cardíaca: 56

Frec. Resp.: 20

Oximetría: 100

PLAN TERAPEUTICO

- Sin conducta Neuroquirúrgico

- Continuar con ATB (empírico)

- Rescate de cultivos

- Pronostico ominoso

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 03:07

Página 4 de 7

23/05/2022 11:11:03

J.Castro

hsa dia 3, fisher 4. angiografia-aneurisma aci bifurcacion trilobulado.
e glasgow 3.
anosocoroia, midriasis izquiada.
pronostico ominoso.

23/05/2022 22:55:15

C.Barra

DIAGNÓSTICOS

- 1.HSA silviana aneurismática H&H 4 /Fisher IV/ WFNS 4 (21/05)
 - Aneurisma trilobulado de la bifurcación de ACI Izquierda (3 lobulos) con cuello ancho
 - Herniación sub faxial de vasos de ACA Izquierda secundario a efecto de masa por hematoma
 - Tratamiento endovascular frustrado (x cuello ancho de aneurisma)
- 2.Neumonía aspirativa en tratamiento
- 3.Antecedentes: HTA, DM2 IR, Obesidad

Sin requerimientos de DVA, afebril, VMI CPAP 6/6 FIO2 35% PAFI 165am

Glicemias estables

BH -3770 Diu 4360 RG 300 Dep -

EXAMEN FÍSICO

Sopor profundo, pupilas anisocóricas, midriasis izquierda, glasgow 3 sin sedación.

Bien perfundida

RR2T NAS

MP+ disminuido bilateral

RHA+ BD

EEII edema no, sin signos de TVP

PLANES

Paciente fuera del alcance Neuroquirúrgico, pronóstico ominoso, familia al tanto

24/05/2022 12:37:22

E.Ramírez

SE HA MANTENIDO GRAVÍSIMO

GLASGOW 4 , SOSTENIDO . SIN SEDACIÓN

SE HA DESESTIMADO TRATAMIENTO ACTIVO, POR MALA CONDICIÓN CLÍNICA

ULTIMO TC CEREBRAL DEL DÍA 21-05-22 (INICIAL), CON GRAN HEMATOMA LENTICULAR IZQUIERDO, SIN HIDROCEFALIA

COMA . GLASGOW 3-4 (RESPUESTA MOTORA MÍNIMA , DE RECOGIMIENTO EN HOMBRO)

TC CEREBRAL DE CONTROL + ANGIO TC , PARA DEFINIR EVENTUAL SÓLO TRATAMIENTO PROPORCIONADO

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 3:07:28

Página 6 de 7

24/05/2022 13:40:42

B.Chavez

Cursa 3er día de hospitalización.

Hematoma intraparenquimatoso FT izquierdo-Hemovertrículo ventrículo lateral izquierdo-3er y 4to ventrículo.

HSA Silviana izquierda.

Aneurisma ACI izquierda.

HTA-DM2 IR-obesidad.

Actual:

infartos supra e infratentoriales múltiples secundarios a hipertensión endocraneana.

Hoy evaluado x equipo de neurocx se decide realizar TAC cerebral y angiotac cerebral de control encontrándose infartos.

Paciente grave enVMI sin sedación AO 1 RV 1 RM 2 4/18

mueca al dolor.

febril continua con bomba de metamizol ev medidas físicas.

G 4/15 pupilas hiporeactivas isocóricas.

TOT sin secreciones TB.

cuello sin bocio.

torax csps ventilados

rr 2 t

abdomen bdi

ext sin edema sin tvp.

Hemo: ayer con SLR, se suspende por tendencia a hipernatremia con Hto 45 %

sin necesidad de NA.

respiratorio: TOT con CPAP 35 %.

infeccioso: febril PCR 217 en ascenso con necesidad de bomba de metamizol en tto empírico ampi-sulbactam.

neuocx: evaluado x equipo de neurocx se solicita TAC cerebral de control para evaluar pronóstico. Actualmente en G 3-4/15.

renal: diuresis 2790 cc Na 163 con aporte de agua x SNG y aporte glucosado ev. K 4.7.

nutricional: régimen cero aporte glucosado ev.

24/05/2022 14:22:27

J.Zamora

NC

CT de control con infartos supra e infratentoriales secundarios a hipertensión endocraneana.

GCS 3

Evaluada por equipo NC,

dado estado crítico y CT con aparición de infartos por hipertensión endocraneana, paciente fuera de alcance terapéutico.

Medidas de confort.

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia subaracnoidea aneurismática - infartos supra e infratentoriales múltiples

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallece 2H30

Plan Post Alta

fallece 02H30

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 25/05/2022 03:07

Página 6 de 7

Fecha Última Actualización: 25-05-2022 3:07:28

Página 7 de 7

Tipo de Reposo :

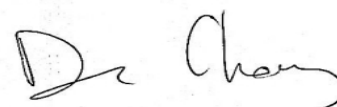
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Boriz Chavez Cedeno

Médico Tratante (Staff)